

BLSD – SEQUENZA OPERATIVA

- Anticipazione (Verifica dei materiali, distribuzione di compiti e ruoli, distribuzione del materiale da portare: zaino, aspiratore, O2, DAE)
- Quick look
- Sicurezza e valutazione ambientale, accessibilità
- Valutazione coscienza. Pizzicare e scuotere le spalle (se non traumatico). Effettuare GAS (8-10 sec.)
- Se paziente supino è preferibile stare alla sua destra.
- Se paziente incosciente chiedere di portare il DAE: **"Porta il DAE"**
- Posiziono, allineo e scopro. Eccezionalmente:
 - Se il trasferimento su piano rigido ritarda la prosecuzione, saltare e procedere con la sequenza. Ok RCP sul letto o divano a patto che si aumenti profondità CTE.
 - Se DAE non disponibile e rimozione vestiti ritarda la prosecuzione, saltare e procedere con la sequenza. Effettuare la rimozione dei vestiti prima di applicare le placche.
- Triplice manovra pervietà vie aeree (apro, guardo, iper estendo).
- Consentito posizionare cannula se questo non ritarda la prosecuzione.
- Effettuare GAS per massimo 10 sec. NO valutazione polso carotideo, ricerca segni di circolo (MOTORE).
- Se paziente in ARRESTO CARDIO CIRCOLATORIO far allertare COP, richiedere ALS, applicare placche (il secondo):
 - "Paziente in ARRESTO CARDIO CIRCOLATORIO, chiama la COP, fai mandare ALS, inizio RCP"
 - Applicare placche stando preferibilmente alla sinistra del paziente.
 - Posizionare placche come da disegni sulle stesse.
- Durante applicazione placche fare RCP 30:2
- Se ventilazioni difficoltose procedere con le sole CTE (Compressioni toraciche)
- La filastrocca "Io sono via, voi siete via, tutti sono via. Via radio, telefono e ossigeno" è espressa dall'operatore DAE ma è l'altro soccorritore che garantisce fisicamente la sicurezza
- Dopo prima analisi ed eventuale scarica, se non sono presenti segni di circolo procedere con RCP30:2.
- Se ventilazioni difficoltose usare tecnica a 2 soccorritori (4 mani)
- All'inizio delle successive analisi effettuare il cambio (girare in senso orario)
- **** NOTE SEQUENZA BLSD**
 - Il solo arresto respiratorio non è più contemplato.
 - Se Covid+ / sospetto sconosciuto applicare raccomandazioni Covid al protocollo.
 - Coscienza dai fianchi
 - Mascherina al paziente.
 - Valutazione respiro (motore) dal fianco.
 - Ventilazione a 2 soccorritori.
 - Se le ventilazioni risultano particolarmente difficoltose e' consentito posizionare cannula. Attenzione al suo inserimento:
 - Nell'adulto inserirla rivolta verso l'alto e poi ruotarla verso il basso.

PBLSD – SEQUENZA OPERATIVA

- Anticipazione (Verifica dei materiali, distribuzione di compiti e ruoli, distribuzione del materiale da portare: zaino, aspiratore, O2, DAE)
- Quick look
- Sicurezza e valutazione ambientale, accessibilità
- Valutazione coscienza. Pizzicare e scuotere le spalle (se non traumatico). Effettuare GAS per valutare MOTORE (8-10 sec.)
- Se paziente supino è preferibile stare alla sua destra.
- Se paziente incosciente chiedere di portare il DAE: **"Porta il DAE"**
- Posiziono, allineo e scopro. Eccezionalmente:
 - Se il trasferimento su piano rigido ritarda la prosecuzione, saltare e procedere con la sequenza. Ok RCP sul letto o divano a patto che si aumenti profondità CTE.
 - Se DAE non disponibile e rimozione vestiti ritarda la prosecuzione, saltare e procedere con la sequenza. Effettuare la rimozione dei vestiti prima di applicare le placche.
- Triplice manovra pervietà vie aeree (apro, guardo, **modica estensione nel bambino, posizione neutra nel lattante**).
- Consentito posizionare cannula se questo non ritarda la prosecuzione.
- Effettuare GAS per massimo 10 sec. NO valutazione polso carotideo, ricerca segni di circolo (MOTORE).
- Se paziente in ARRESTO RESPIRATORIO far allertare COP, richiedere ALS, applicare placche (il secondo):
 - "Paziente in RESPIRATORIO, chiama la COP, fai mandare ALS, inizio RCP"
 - Applicare placche stando preferibilmente alla sinistra del paziente.
- **Effettuare 5 insufflazioni di soccorso delle quali almeno 2 efficaci.**
- Rapida ricerca dei segni di circolo, solo MOTORE, no polso carotideo, se assenti iniziare RCP 15:2 e applicare placche.
- Posizionare placche come da disegni sulle stesse.
- La placca posteriore si applica mettendo il paziente sul fianco.
- Se in fascia 0-8 anni non sono disponibili placche pediatriche utilizzare placche adulto (comunicare a COP)
- Nel lattante preferibile CTE a "2 pollici", se soccorritore unico CTE a "2 dita"
- Se bambino compressioni ad una mano posizionata 2 dita sopra il punto di rieperie
- Durante applicazione placche fare RCP 15:2
- Se ventilazioni difficoltose procedere con le sole CTE (Compressioni toraciche)
- La filastrocca "Io sono via, voi siete via, tutti sono via. Via radio, telefono e ossigeno" è espressa dall'operatore DAE ma è l'altro soccorritore che garantisce fisicamente la sicurezza
- Dopo prima analisi ed eventuale scarica, se non sono presenti segni di circolo procedere con RCP 15:2.
- Se ventilazioni difficoltose usare tecnica a 2 soccorritori (4 mani)
- All'inizio delle successive analisi effettuare il cambio (girare in senso orario)
- **** NOTE SEQUENZA BLSD**
 - Se il paziente è piccolo comprimere il pallone di ventilazione con una
 - Se le ventilazioni risultano particolarmente difficoltose e' consentito posizionare cannula. Attenzione al suo inserimento:
 - Nel bambino inserirla rivolta verso la guancia e poi ruotarla verso il basso.
 - Nel lattante inserirla rivolta verso il basso con l'aiuto di un abbassa lingua
 - Il solo arresto respiratorio non è più contemplato.
 - Se Covid+ / sospetto sconosciuto applicare raccomandazioni Covid al protocollo.

- Coscienza dai fianchi
- Mascherina al paziente.
- Valutazione respiro (motore) dal fianco.
- Ventilazione a 2 soccorritori.